

CAPÍTULO 11.2

Insuficiencia Renal Aguda o Crónica

PERFIL EUNACOM 1.06.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Trastornos Hidroelectrolíticos — Clase 2

> **Nota:** El transcripto de esta clase está dañado en la fuente. Este artículo será completado cuando se disponga del archivo correcto.

Contenido Esperado (basado en contexto del módulo)

Esta clase probablemente cubre uno de los siguientes temas del módulo de Nefrología:

- Hipernatremia: causas, diagnóstico y manejo
- Diabetes insípida (central vs. nefrogénica)
- Trastornos del potasio (hipokalemia / hiperkalemia)
- Balance ácido-base: tipos de acidosis y alcalosis

Estado: Pendiente de actualización.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 62 años, diabético tipo 2 de 15 años de evolución, consulta por hallazgo de creatinina de 2.1 mg/dL en exámenes de rutina. Se solicita ecografía renal que muestra riñones de tamaño normal sin atrofia. ¿Cuál es la interpretación más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Insuficiencia Renal Aguda o Crónica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La ecografía renal es el estudio más importante para diferenciar IRA de IRC.
- Riñones normales en ecografía orientan a insuficiencia renal aguda.
- Riñones atróficos o pequeños en ecografía orientan a insuficiencia renal crónica.
- La diabetes es la causa más frecuente de IRC y cursa con riñones grandes (confunde con IRA).
- Otras causas de IRC con riñones grandes: mieloma, amiloidosis, VIH, VHC, VHB.
- El riñón poliquístico tiene riñones grandes pero la ecografía hace el diagnóstico de inmediato.
- Si la causa es clara y la IRA es leve, se puede tratar directamente sin ecografía y controlar.
- La IRA prerrenal por deshidratación se maneja con hidratación y control de creatinina.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INSUFICIENCIA RENAL AGUDA O CRÓNICA)

PREGUNTA 1

Paciente de 62 años, diabético tipo 2 de 15 años de evolución, consulta por hallazgo de creatinina de 2.1 mg/dL en exámenes de rutina. Se solicita ecografía renal que muestra riñones de tamaño normal sin atrofia. ¿Cuál es la interpretación más adecuada?

- A) Los riñones normales descartan insuficiencia renal crónica
- B) Se trata seguramente de una insuficiencia renal aguda prerrenal
- C) La diabetes puede causar IRC con riñones grandes, no se descarta cronicidad
- D) Se debe repetir la ecografía en 3 meses para confirmar
- E) Es un riñón poliquístico

PREGUNTA 2

Paciente de 30 años consulta por diarrea de 3 días de evolución con signos de deshidratación severa. Los exámenes muestran creatinina de 1.4 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Solicitar ecografía renal urgente
- B) Solicitar biopsia renal
- C) Hidratar, controlar creatinina y solicitar ecografía solo si no revierte
- D) Iniciar diálisis de urgencia
- E) Derivar a nefrología para estudio de IRC

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes causas de insuficiencia renal crónica NO cursa con riñones grandes en la ecografía?

- A) Nefropatía diabética
- B) Nefropatía por VIH
- C) Riñón poliquístico
- D) Hipertensión arterial crónica
- E) Amiloidosis renal

RESUMEN: INSUFICIENCIA RENAL AGUDA O CRÓNICA

Esta clase aborda cómo diferenciar la insuficiencia renal aguda de la crónica en la práctica clínica, dado que el paciente habitualmente no sabe cuánto tiempo lleva con la creatinina elevada. El estudio más importante es la ecografía renal: riñones normales sugieren insuficiencia renal aguda, mientras que riñones atróficos o pequeños orientan a insuficiencia renal crónica. Sin embargo, existen causas de insuficiencia renal crónica con riñones grandes que pueden confundirse con aguda: diabetes (la causa más frecuente de IRC), riñón de mieloma, amiloidosis, infecciones crónicas por VIH, VHC o VHB, y riñón poliquístico. Cuando la causa es clara y la insuficiencia renal aguda es leve (por ejemplo, deshidratación con creatinina de 1.3-1.4), se puede tratar directamente y controlar, reservando la ecografía solo si no revierte en el corto plazo.